Estações OSCE — Emergencias Neurologicas

10 estações · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#213** — Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito (avc hemorragico)
2. **#248** — Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora (avc isquemico)
3. **#249** — Convulsão contínua há 10 minutos no PS (estado de mal epileptico)
4. **#250** — Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca (meningite bacteriana)
5. **#251** — Pior dor de cabeça da vida de início súbito (hemorragia subaracnoidea)
6. **#252** — Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória (crise miastenica)
7. **#253** — Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias (sindrome de guillain barre)
8. **#254** — Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico (encefalopatia de wernicke)
9. **#255** — Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE (hipertensao intracraniana)
0. **#256** — Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia (trombose venosa cerebral)

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #213 · UPA — Urgência e Emergência · nível complexo

Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito

CENÁRIO

Urgência e Emergência — UPA. Sala de emergência, turno matutino. Paciente chega trazido pela esposa.

PACIENTE

R.F.B., 58 anos, masculino, comerciante, hipertenso há 10 anos, em uso irregular de losartana, tabagista 20 maços-ano.

QUEIXA PRINCIPAL

Esposa refere que o marido teve cefaleia súbita muito intensa há 1 hora, com fraqueza no lado direito do corpo e dificuldade para falar.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida ao caso (com o paciente e a esposa como informantes).
2. Realize o exame físico neurológico e geral pertinente.
3. Calcule o escore NIHSS de forma simplificada e interprete.
4. Solicite os exames complementares imediatos adequados à hipótese diagnóstica.
5. Proponha a conduta terapêutica inicial baseada no diagnóstico de imagem.
6. Oriente a família sobre o diagnóstico, a gravidade e os próximos passos.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #213 · UPA — Urgência e Emergência · nível complexo

Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura	IMC
218/124 mmHg	96 bpm	20 irpm	37,0 °C	88 kg	1,74 m	29,1 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, torporoso (Glasgow 12 — O3V4M5), sudoreico, com desvio de comissura labial à direita visível.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: nível de consciência reduzido (GCS 12); afasia motora (fala reduzida, palavras isoladas); pupilas isocóricas (4mm) fotorreagentes bilateralmente; desvio do olhar conjugado para a ESQUERDA; paralisia facial central à direita; hemiparesia direita — força 2/5 em membro superior e 3/5 em membro inferior; reflexo cutâneoplantar em extensão (Babinski) à direita; sensibilidade difícil de avaliar
- CARDIOVASCULAR: bulhas rítmicas normofonéticas, sem sopros; FC 96 bpm
- RESPIRATÓRIO: MV presente bilateralmente, sem ruídos adventícios; FR 20 irpm
- ABDOME: sem alterações relevantes

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Glicemia capilar (HGT)	**142 mg/dL**	70–99 mg/dL
Hemograma — Hemoglobina	14,8 g/dL	13,5–17,5 g/dL
Hemograma — Plaquetas	198.000/mm³	150.000–400.000/mm³
TP/INR	1,1	0,8–1,2
TTPA	32 s	25–35 s
Creatinina	1,2 mg/dL	0,7–1,2 mg/dL
Sódio	138 mEq/L	136–145 mEq/L

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC de crânio SEM contraste (resultado imediato — entregar se o candidato solicitar TC de crânio): Hiperdensidade espontânea em núcleo lentiforme esquerdo (putame), compatível com hematoma hipertensivo. Volume estimado ~35 mL (Fórmula ABC/2). Desvio de linha média de 5 mm para a direita. Edema perilesional discreto. Sem hidrocefalia obstrutiva. Sem herniação uncal visível.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #213 · UPA — Urgência e Emergência · nível complexo

Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais ao início. Entregar HGT ao início. Entregar demais labs se solicitados. Entregar a TC de crânio SOMENTE se o candidato solicitar TC de crânio SEM contraste (não entregar se solicitar apenas "exames de imagem" sem especificar, e NÃO entregar se o candidato solicitar trombolítico antes de ver a imagem — este é o erro crítico do caso). ATENÇÃO: Se o candidato solicitar alteplase/rtPA antes da TC, informar que não foi coletada a imagem ainda e aguardar a conduta do candidato.

PERFIL DO PACIENTE

R.F.B., 58 anos, masculino, comerciante, casado, 2 filhos. Hipertenso há 10 anos — usa losartana 50mg mas toma irregular ("só quando lembra"). Tabagista 20 maços-ano. Nega diabetes e cardiopatia. Nega uso de anticoagulantes.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Esposa — relato inicial	“Doutor, meu marido tava tomando café da manhã quando de repente ele falou que tinha uma dor de cabeça horrível, a pior da vida dele. Aí eu vi que o canto da boca dele tava torto e ele começou a arrastar a fala. Trouxe correndo.”
Paciente — queixa (afasia)	“(Fala apenas palavras soltas, com dificuldade) "Cabeça... dói muito... braço... não mexe..."”
Esposa — sobre a cefaleia	“A dor de cabeça foi de uma hora pra outra, do nada. Ele nunca teve dor de cabeça assim antes. Falou que era como se tivesse levado uma pancada.”
Esposa — sobre os medicamentos	“Ele tem pressão alta faz anos, mas toma o remédio de vez em quando só. Semana passada foi ao cardiologista e a pressão tava 200 e alguma coisa.”
Esposa — sobre anticoagulantes	“Não toma nenhum remédio pra afinar o sangue. Só losartana.”
Esposa — sobre tempo de início	“Faz exatamente uma hora, eu olhei no relógio porque fiquei desesperada.”
Esposa — pergunta ativa	“Doutor, é derrame? Vai ficar assim? Precisa de cirurgia?”
Esposa — pergunta ativa	“Pode dar aquela injeção que dissolve o coágulo? Vi na internet que existe um remédio assim.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Uso irregular da losartana — toma "só quando lembra", última dose há 3 dias — só revela se o candidato perguntar especificamente sobre adesão ao anti-hipertensivo
- Episódio de cefaleia intensa 2 semanas atrás que passou sozinha (possível "sentinel headache" de sangramento menor) — só revela se o candidato perguntar sobre episódios anteriores semelhantes
- Sem histórico de AVC ou TIA prévios — revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Esposa muito ansiosa e assustada, chora durante a consulta. Fornece as informações com clareza quando questionada objetivamente. Fica mais tranquila se o candidato demonstrar que está agindo rapidamente. Pode questionar sobre o uso de trombolítico por ter visto na internet — candidato deve explicar a contraindicação após TC confirmar sangramento. O paciente é colaborativo mas com afasia motora — fala apenas palavras isoladas.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #213 · UPA — Urgência e Emergência · nível complexo

Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito

AVC hemorrágico (AVEH) hipertensivo — hematoma intraparenquimatoso em núcleo lentiforme esquerdo (putame), volume ~35 mL, com desvio de linha média de 5 mm. Hipertensão arterial não controlada como etiologia principal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- AVC isquêmico — quadro neurológico focal agudo idêntico; distinguido pela TC de crânio SEM contraste (hiperdensidade = sangue = hemorrágico; hipodensidade tardia = isquêmico); A TROMBOLÍSE É CONTRAINDICADA NO AVEH
- Hemorragia subaracnoide (HSA) — cefaleia em trovoada; sangue nas cisternas basais e na fissura silviana; geralmente sem déficit motor focal inicial; TC mostra hiperdensidade diferente (difusa, subaracnoide)
- Crise epiléptica seguida de paralisia de Todd — deficit motor pós-ictal transitório; geralmente sem cefaleia in trovão; afastado pela neuroimagem
- Encefalopatia hipertensiva — alteração difusa de consciência, cefaleia, vômitos; sem déficit focal; PRES na RM; PA muito elevada; afastado pelo achado focal na TC

CONTEXTO CLÍNICO

Homem de 58 anos, hipertenso não controlado (PA 218/124), tabagista, em uso irregular de anti-hipertensivo, com instalação hiperaguda de déficit neurológico focal (hemiparesia direita, afasia motora, desvio conjugado do olhar à esquerda, paralisia facial central direita) e cefaleia explosiva. TC de crânio confirma hematoma intraparenquimatoso em putame esquerdo com desvio de linha média de 5 mm — padrão típico de AVEH hipertensivo.

JUSTIFICATIVA

Localização putaminal é a mais comum no AVEH hipertensivo (40–50% dos casos), seguida por tálamo, cerebelo e tronco cerebral. Volume > 30 mL em hematoma supratentorial com desvio de LM > 3 mm indica risco aumentado de herniação e é critério de discussão neurocirúrgica. NIHSS estimado: nível consciência (1) + desvio do olhar (2) + paralisia facial (1) + motor braço D (3) + motor perna D (2) + afasia (2) = ~11 pontos (déficit moderado-grave). Trombolíticos são absolutamente contraindicados no AVEH.

ANAMNESE ESPERADA

- Investigar início (tempo exato desde o início dos sintomas) e modo de instalação (súbito = vascular)
- Caracterizar sintomas: cefaleia (intensidade, "pior da vida"), déficit motor, alteração da fala
- Perguntar sobre HAS e controle — adesão ao tratamento
- Investigar uso de anticoagulantes, antiagregantes, cocaína/anfetaminas (causas de AVEH em jovens)
- Perguntar sobre AVC/TIA prévios
- Investigar tabagismo, diabetes, cardiopatia
- Questionar episódios sentinela (cefaleia recente)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Avaliar nível de consciência (GCS/escala de alerta)
- Calcular NIHSS simplificado: consciência, olhar, campos visuais, paralisia facial, motor MMSS e MMII, ataxia, sensibilidade, linguagem/afasia, disartria, extinção
- Avaliar pupilas (midriana unilateral = sinal de herniação uncal iminente)
- Verificar sinais vitais com ênfase na PA
- Auscultar coração (FA como causa de AVC isquêmico)
- Fundoscopia (papiledema = HIC)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC de crânio SEM contraste (URGENTE)	Exame de imagem de escolha e obrigatório imediato — diferencia AVEH de AVCi ANTES de qualquer decisão terapêutica; disponível e rápido	Hiperdensidade putaminal esquerda — hematoma hipertensivo ~35 mL, desvio de LM 5 mm
Glicemia capilar (HGT)	Hipoglicemia e hiperglicemia podem mimetizar déficit neurológico focal; deve ser coletada na chegada	142 mg/dL — discreta hiperglicemia de estresse
Coagulograma (TP/INR, TTPA, plaquetas)	Avaliar coagulopatia que possa expandir o hematoma; necessário antes de qualquer intervenção	Normal — sem coagulopatia
Hemograma, creatinina, eletrólitos	Avaliação geral e suporte à conduta clínica	Dentro da normalidade

CONDUTA ESPERADA

- Monitorização e suporte: Monitorização contínua (ECG, PA não invasiva, SatO2, glicemia); acesso venoso calibroso; cabeceira a 30°; oxigenoterapia se SatO2 < 95%; evitar glicose hipotônica
- Controle pressórico: Meta PA ≤ 140/90 mmHg nas primeiras 24h (evidência CLASS IIa para hematoma sem HIC grave); Labetalol IV 20 mg em bolus (não disponível no SUS → Nitroprussiato de sódio 0,5–8 mcg/kg/min) — CUIDADO: hipotensão abrupta piora perfusão perihematoma
- Avaliar indicação neurocirúrgica: Volume > 30 mL + desvio LM > 3 mm em paciente jovem com GCS < 8 ou deterioração clínica = discutir com neurocirurgia; escore ICH Score para prognóstico
- CONTRAINDICADO: alteplase/rtPA (trombolítico) — absolutamente contraindicado em AVEH confirmado
- Profilaxia: antiepiléptico profilático não é rotina (mas tratar crises se ocorrerem); profilaxia de TVP com compressão pneumática; controle glicêmico; prevenção de úlceras
- Encaminhamento: UTI neurológica; comunicar neurocirurgia; contato com serviço de referência (SAMU/remoção se necessário)
- Orientação familiar: comunicar diagnóstico com clareza; explicar impossibilidade do uso de trombolítico por ser sangramento (não coágulo); orientar sobre prognóstico guardado

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Apresentar-se pelo nome
- Comunicar o diagnóstico de "derrame cerebral por sangramento" de forma clara à esposa
- Explicar objetivamente POR QUÊ o trombolítico não pode ser usado — é sangramento, não coágulo
- Demonstrar empatia sem gerar desespero
- Explicar que está sendo tomando todas as medidas necessárias
- Perguntar se tem dúvidas

ERROS CRÍTICOS

- Prescrever alteplase (rtPA) sem realizar TC de crânio — ERRO FATAL: trombolítico em AVEH causa expansão do hematoma e morte
- Não solicitar TC de crânio de forma emergencial ao chegar um AVC agudo
- Não controlar a pressão arterial (PA 218/124 mmHg sem tratamento favorece expansão do hematoma)
- Não calcular GCS ou avaliar o nível de consciência (fundamental para estadiamento e decisão neurocirúrgica)
- Não comunicar a neurocirurgia (volume > 30 mL com desvio de LM requer avaliação especializada urgente)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #213 · UPA — Urgência e Emergência · nível complexo

Cefaleia súbita e fraqueza no hemicorpo direito

CHECKLIST — CEFALEIA SÚBITA E HEMIPARESIA (AVEH)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Apresentou-se ao paciente e à esposa CFM Res. 2.232/2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou o diagnóstico à família com clareza, explicando por que o trombolítico não pode ser usado Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Definiu o tempo de início dos sintomas (fundamental para triagem terapêutica) Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou uso de anticoagulantes e anti-hipertensivos (adesão) Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre HAS e controle pressórico prévio Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Avaliou nível de consciência (GCS) Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Realizou exame neurológico focal (motor, pupilas, olhar, facial, fala) Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Coletou HGT/glicemia capilar Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou TC de crânio SEM contraste de forma emergencial Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou o AVEH pela TC e contraindicou o trombolítico Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA IMEDIATA	Pts	Avaliação
Iniciou controle pressórico imediato (meta PA ≤ 140 mmHg) Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou internação em UTI e acionou neurocirurgia Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
NÃO prescreveu alteplase/trombolítico Diretriz AVC SBN/ABN, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **9,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #248 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora

CENÁRIO

Pronto-socorro de hospital terciário, 09h30. Paciente trazido pelo SAMU após queda em casa.

PACIENTE

Roberto Alves, 68 anos, masculino, aposentado, hipertenso e diabético.

QUEIXA PRINCIPAL

Fraqueza súbita no hemicorpo esquerdo associada a desvio da rima labial iniciados há aproximadamente 1 hora.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Aplique a escala de Cincinnati e a escala NIHSS.
2. Realize a anamnese dirigida ao protocolo de AVC.
3. Solicite e interprete os exames complementares urgentes.
4. Avalie critérios de elegibilidade para trombólise IV (rt-PA).
5. Comunique o diagnóstico e condutas à família.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #248 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow	Peso	Altura
178/102 mmHg	88 bpm	18 irpm	37,0 °C	96% (ar ambiente)	14 (O4V4M6)	82 kg	1,72 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, consciente, orientado no tempo e espaço, afasia parcial (disfasia de expressão), colaborativo.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: paresia facio-braquio-crural esquerda grau 3/5, reflexo cutâneo-plantar em extensão à esquerda, desvio da rima labial para direita, disdiadococinesia esquerda.
- CARDIOVASCULAR: ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem sopros.
- RESPIRATÓRIO: murmúrio vesicular presente bilateralmente, sem ruídos adventícios.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Glicemia capilar	**142 mg/dL**	70–99 mg/dL
Hemograma	Normal	
Coagulograma (TAP/INR)	INR 1,1	0,8–1,2
Plaquetas	198.000/mm³	150.000–400.000
Creatinina	1,1 mg/dL	0,7–1,3
TC crânio sem contraste	Sem hiperdensidade ou hipodensidade precoce. Score ASPECTS = 9.	

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC de crânio sem contraste: ausência de hiperdensidade ou áreas de hipodensidade precoce. ASPECTS = 9. Sem desvio de linha média.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #248 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora

NOTA AO AVALIADOR

Entregar o resultado da TC imediatamente após o candidato solicitá-la. Revelar resultado do ECG (FA paroxística) apenas se candidato pedir.

PERFIL DO PACIENTE

Homem de 68 anos, ex-fumante (parou há 10 anos), HAS há 15 anos, DM2 há 8 anos. Mora com a esposa. Usa amlodipina e metformina. Acorda com déficit.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, eu não consigo mover o meu braço esquerdo direito. Tá fraco. Aconteceu do nada, tava tomando café.”
Sobre início dos sintomas	“Foi às 8h30, eu tava sentado na mesa do café. De repente o braço ficou pesado e eu caí da cadeira.”
Sobre dor de cabeça	“Não, não tô com dor de cabeça não.”
Sobre medicações	“Tomo pressão, amlodipina, e a metformina pro diabetes. Todo dia.”
Sobre anticoagulantes ou AAS	“Não, não tomo nenhum sangue fino.”
Sobre cirurgia recente	“Fiz uma cirurgia no joelho há 4 meses, mas já tá tudo bem.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“O que eu tive, doutor? É derrame?”
Sobre AVC ou episódio anterior	“Nunca tive nada assim antes não.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Fibrilação atrial paroxística — só revela se o candidato solicitar ECG
- Etilismo social moderado — só revela se candidato perguntar sobre álcool

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansioso, com dificuldade leve para formar frases completas (disfasia). Responde perguntas diretas. A esposa pode complementar informações se o candidato se dirigir a ela.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #248 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora

AVC Isquêmico agudo em território da artéria cerebral média direita (ACM D), com janela terapêutica ativa para trombólise IV.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- AVC Hemorrágico — entra pelo déficit focal súbito e HAS; sai pela TC sem hiperdensidade e ausência de cefaleia intensa/vômitos
- Hipoglicemia — entra pelo déficit focal e DM; sai pela glicemia de 142 mg/dL
- Crise epiléptica com paralisia de Todd — entra pelo déficit focal; sai pela ausência de história de epilepsia e pelo déficit persistente sem convulsão testemunhada
- Lesão estrutural (tumor cerebral) — entra pelo déficit focal; sai pelo início súbito e TC sem lesão focal

CONTEXTO CLÍNICO

O AVC isquêmico representa 85% dos AVCs e é a principal causa de incapacidade em adultos no Brasil. Fatores de risco incluem HAS, DM, FA e tabagismo. A janela para trombólise IV com alteplase é de 4,5 horas do início dos sintomas.

JUSTIFICATIVA

Déficit facio-braquio-crural esquerdo de início súbito, TC sem hemorragia, NIHSS compatível com AVC moderado, dentro da janela de 4,5h, sem contraindicações absolutas identificadas.

ANAMNESE ESPERADA

- Horário exato do início dos sintomas
- Uso de anticoagulantes ou antiagregantes
- Cirurgia recente (< 3 meses)
- HAS, DM, tabagismo, FA
- AVC ou TIA prévio
- Nível basal funcional
- Alergias

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Escala de Cincinnati (FAST)
- NIHSS completo
- Fundoscopia (papiledema)
- Ausculta cardíaca (FA)
- PA nos dois membros
- Glasgow

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC crânio sem contraste	Excluir hemorragia antes de trombólise	Sem hiperdensidade — elegível para rt-PA
Glicemia capilar	Excluir hipoglicemia como causa reversível	142 mg/dL — não justifica déficit
Coagulograma + plaquetas	Critério de elegibilidade para trombólise	Dentro da normalidade
ECG 12 derivações	Pesquisar FA como fonte embólica	FA paroxística
AngioTC de crânio e pescoço	Avaliar oclusão arterial para trombectomia mecânica	Oclusão M1 da ACM D

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: Alteplase 0,9 mg/kg IV (máx 90 mg), 10% em bolus + 90% em 60 min; AAS 100–300 mg VO após 24h (após repetir TC)
- Não farmacológica: Internação em Unidade de AVC; cabeceira a 0–30°; controle glicêmico (alvo 140–180 mg/dL); monitorização contínua; NPO até avaliação de deglutição
- Orientações: Explicar diagnóstico; informar sobre trombectomia mecânica se houver oclusão proximal

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Apresentar-se pelo nome
- Aplicar FAST/Cincinnati na triagem
- Informar diagnóstico provável à família
- Explicar risco-benefício da trombólise
- Solicitar assinatura do TCLE
- Comunicar achados ao neurorradiologista/neurologista

ERROS CRÍTICOS

- Não verificar glicemia antes de administrar trombólise
- Administrar trombólise sem excluir hemorragia na TC
- Não calcular a janela terapêutica (horário do início dos sintomas)
- Administrar anticoagulante pleno nas primeiras 24h pós-trombólise
- Não monitorizar PA durante e após alteplase (meta < 180/105 mmHg)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #248 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza súbita no lado esquerdo há 1 hora

AVC Isquêmico — Material de Estudo

Definição e Epidemiologia	Pts	Avaliação
AVC isquêmico: oclusão arterial com infarto do parênquima cerebral. Representa 85% dos AVCs. Diretrizes SBN 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Principal causa de incapacidade e 2ª causa de morte no Brasil. SVS/MS 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Fatores de risco modificáveis: HAS, DM, FA, tabagismo, dislipidemia, obesidade. AHA/ASA Guidelines 2021	1	☐ A ☐ P ☐ I

Diagnóstico e Escalas	Pts	Avaliação
Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS): desvio facial, fraqueza de braço, alteração de fala — 1 item alterado = 72% VPP para AVC. Kothari 1999	2	☐ A ☐ P ☐ I
NIHSS: avalia consciência, olhar, visual, facial, motor, ataxia, sensibilidade, linguagem, disartria, extinção. Guia severidade e terapêutica. Brott et al. 1989	2	☐ A ☐ P ☐ I
TC crânio sem contraste: exame inicial obrigatório — excluir hemorragia antes de trombólise. AHA/ASA 2019	2	☐ A ☐ P ☐ I

Trombólise IV (rt-PA / Alteplase)	Pts	Avaliação
Janela: até 4,5 horas do início dos sintomas (ou último visto bem). ECASS III, AHA/ASA 2019	2	☐ A ☐ P ☐ I
Dose: 0,9 mg/kg IV (máx 90 mg): 10% em bolus, 90% em 60 minutos. AHA/ASA 2019	2	☐ A ☐ P ☐ I
Contraindicações absolutas: hemorragia na TC, INR > 1,7, plaquetas < 100.000, glicemia < 50 ou > 400 mg/dL, cirurgia de grande porte < 14 dias, AVC < 3 meses. Diretrizes SBN 2022	2	☐ A ☐ P ☐ I
Meta de PA antes e durante trombólise: < 185/110 mmHg. AHA/ASA 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I

Trombectomia Mecânica	Pts	Avaliação
Indicada em oclusão de grande vaso (ACM M1, carótida intracraniana, basilar) até 24h com imagem selecionada. DAWN/DEFUSE 3 trials	2	☐ A ☐ P ☐ I
Não substitui trombólise IV — complementar quando elegível. AHA/ASA 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I

Cuidados na Fase Aguda	Pts	Avaliação
Internação em Unidade de AVC reduz mortalidade e incapacidade em 20–25%. Cochrane 2013	1	☐ A ☐ P ☐ I
Cabeceira a 0–30° nas primeiras 24h (melhora perfusão cerebral). Diretrizes SBN 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I

Controle glicêmico: alvo 140–180 mg/dL; hipoglicemia piora prognóstico. AHA/ASA 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I
NPO até avaliação fonoaudiológica da deglutição (risco de aspiração). Diretrizes SBN 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **23** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #249 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Convulsão contínua há 10 minutos no PS

CENÁRIO

PS de hospital geral, 22h. Paciente trazido pelo SAMU em convulsão tônico-clônica generalizada contínua.

PACIENTE

Marcos Ferreira, 34 anos, masculino, comerciante, epiléptico em uso irregular de medicação.

QUEIXA PRINCIPAL

Convulsão tônico-clônica generalizada sem recuperação da consciência há 10 minutos.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a estabilização inicial (ABC) e trate o status epilepticus em protocolo escalonado.
2. Solicite e interprete os exames complementares urgentes.
3. Identifique e trate a causa precipitante.
4. Oriente a família sobre o diagnóstico e prevenção de novas crises.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #249 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Convulsão contínua há 10 minutos no PS

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
152/94 mmHg	118 bpm	20 irpm	37,8 °C	91% (ar ambiente)	6 (durante crise)

EXAME FÍSICO GERAL

Mal estado geral, inconsciente, movimentos tônico-clônicos generalizados contínuos, cianose perioral, hipersalivação.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: glasgow 6 durante crise, sem resposta a comandos verbais, pupila midriática bilateral reagente.
- RESPIRATÓRIO: SpO2 91%, estertores de aspiração bilaterais.
- CARDIOVASCULAR: taquicardia sinusal, sem sopros.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Glicemia capilar	**58 mg/dL**	70–99 mg/dL
Sódio	**131 mEq/L**	136–145 mEq/L
Potássio	4,1 mEq/L	3,5–5,0 mEq/L
Ureia	28 mg/dL	15–40 mg/dL
Creatinina	0,9 mg/dL	0,7–1,3
Nível sérico de fenitoína	**4,2 µg/mL**	10–20 µg/mL

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC de crânio: sem lesão estrutural aguda, sem hemorragia, sem hidrocefalia.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #249 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Convulsão contínua há 10 minutos no PS

NOTA AO AVALIADOR

O paciente não pode fornecer história — ator representa familiar. Revelar nível sérico de fenitoína apenas se candidato solicitar. Revelar sódio de 131 quando exames forem solicitados.

PERFIL DO PACIENTE

Epiléptico há 6 anos, em uso de fenitoína 300 mg/dia. Familiar refere que o paciente "esqueceu" de tomar a medicação nos últimos 3 dias. Etilismo social.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal (familiar)	“Ele tava em casa quando começou a convulsionar, a gente contou 10 minutos e ele não parou. É a segunda crise dele hoje.”
Sobre medicação	“Ele usa fenitoína todo dia, mas nesses últimos dias ele esqueceu. A gente tava viajando.”
Sobre epilepsia	“Tem epilepsia há uns 6 anos. Normalmente as crises passam sozinhas em 2 minutos.”
Sobre álcool	“Ele bebe socialmente, tomou umas cervejas ontem à noite.”
Sobre febre ou infecção	“Não, não tinha febre. Tava bem até a crise.”
Sobre trauma de cabeça	“Não caiu, não bateu a cabeça.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Uso irregular de fenitoína nos últimos 3 dias — revela se perguntar sobre medicação
- Ingestão de álcool na véspera — revela se perguntar sobre etilismo

COMPORTAMENTO DO ATOR

Familiar (cônjuge) extremamente ansioso, chorando. Responde perguntas mas interrompe para perguntar "ele vai ficar bem?" a cada momento.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #249 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Convulsão contínua há 10 minutos no PS

Estado de mal epiléptico tônico-clônico generalizado por descontinuação de antiepiléptico (fenitoína subterapêutica) associada a hiponatremia e hipoglicemia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Meningite bacteriana — entra por crise + febre leve; sai pela ausência de rigidez de nuca e febre franca
- AVC — entra pelo déficit neurológico; sai pela TC sem lesão e pelo contexto de epilepsia conhecida
- Intoxicação exógena — entra pelo rebaixamento; sai pelo nível de fenitoína subterapêutico e hiponatremia explicando a crise
- Encefalopatia metabólica — entra pela hiponatremia e hipoglicemia; pode coexistir como fator precipitante

CONTEXTO CLÍNICO

Status epilepticus é definido como crise > 5 min ou duas crises sem recuperação entre elas. Mortalidade de 20–30% se não tratado. Principais causas: descontinuação de AED, hiponatremia, hipoglicemia, infecção do SNC, trauma.

JUSTIFICATIVA

Crise > 10 min, nível de fenitoína subterapêutico (4,2 µg/mL), sódio 131 mEq/L e glicemia 58 mg/dL — múltiplos fatores precipitantes identificados.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo de crise
- Crises prévias hoje
- Uso e adesão a AED
- Última dose de medicação
- Febre, infecção
- Trauma craniano
- Uso de álcool ou drogas
- História de epilepsia

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Glasgow
- Pupilas
- Sinais meníngeos
- SpO2 e padrão respiratório
- Glicemia capilar imediata

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Glicemia capilar imediata	Excluir hipoglicemia — tratável imediatamente	58 mg/dL — hipoglicemia presente
Eletrólitos séricos	Hiponatremia é causa corrigível de crise refratária	Na 131 mEq/L
Nível sérico de fenitoína	Avaliar adesão ao AED	4,2 µg/mL — subterapêutico
TC crânio	Excluir lesão estrutural	Sem lesão aguda
Punção lombar (se febre)	Excluir meningite se houver suspeita clínica	LCR normal (se realizado)

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica (protocolo escalonado): 1ª linha — Diazepam 10 mg IV (ou midazolam 10 mg IM); 2ª linha — Fenitoína 20 mg/kg IV (50 mg/min) ou Valproato 40 mg/kg IV; 3ª linha (refratário) — Intubação + anestesia geral (propofol ou midazolam contínuo)
- Suporte: Glicose 50% 50 mL IV para hipoglicemia; O2 suplementar; posição de segurança; acesso venoso calibroso
- Monitorização: ECG contínuo durante infusão de fenitoína (risco de arritmia)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Chamar ajuda (residentes, anestesia)
- Comunicar diagnóstico ao familiar
- Explicar tratamento escalonado
- Orientar sobre importância da adesão ao AED após recuperação

ERROS CRÍTICOS

- Não corrigir hipoglicemia antes de administrar antiepiléptico
- Não estabelecer via aérea (O2 suplementar / IOT) com SpO2 < 92%
- Infundir fenitoína em velocidade > 50 mg/min (risco de arritmia e hipotensão)
- Não progredir para 2ª linha em 5 min após falha do benzodiazepínico
- Realizar punção lombar sem TC prévia em paciente com rebaixamento de consciência

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #249 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Convulsão contínua há 10 minutos no PS

Estado de Mal Epiléptico — Material de Estudo

Definição e Classificação	Pts	Avaliação
Status epilepticus (SE): crise ≥ 5 min ou ≥ 2 crises sem recuperação completa da consciência. ILAE 2015	2	☐ A ☐ P ☐ I
SE refratário: sem resposta a 2 linhas de tratamento; superrefratário: > 24h mesmo com anestesia geral. Brophy et al. 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I

Protocolo de Tratamento (escalonado)	Pts	Avaliação
1ª linha (0–5 min): Benzodiazepínico — diazepam 10 mg IV ou midazolam 10 mg IM. Diretrizes ILAE / ABE 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I
2ª linha (5–20 min): Fenitoína 20 mg/kg IV (50 mg/min) ou valproato 40 mg/kg IV ou levetiracetam 60 mg/kg IV. ESETT Trial 2019	2	☐ A ☐ P ☐ I
3ª linha (> 20 min, SE refratário): Anestesia geral — propofol, midazolam ou tiopental em infusão contínua + IOT. Brophy et al. 2012	2	☐ A ☐ P ☐ I

Causas e Fatores Precipitantes	Pts	Avaliação
Causas agudas: AVC, meningite/encefalite, traumatismo craniano, distúrbios metabólicos (hiponatremia, hipoglicemia). DeLorenzo et al. 1996	1	☐ A ☐ P ☐ I
Causas crônicas: epilepsia conhecida com descontinuação de AED, nível subterapêutico de antiepiléptico. DeLorenzo et al. 1996	1	☐ A ☐ P ☐ I
Sempre corrigir hipoglicemia e hiponatremia imediatamente — são causas tratáveis. Neurocritical Care Society 2012	2	☐ A ☐ P ☐ I

Monitorização e Suporte	Pts	Avaliação
Monitorização contínua: SpO2, ECG, PA. Fenitoína IV pode causar bradicardia e hipotensão — infundir lentamente (≤ 50 mg/min). Shorvon 2011	2	☐ A ☐ P ☐ I
EEG contínuo indicado no SE refratário para avaliar resposta ao tratamento e descartar SE não-convulsivo. ACNS 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **16** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #250 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca

CENÁRIO

PS de hospital universitário, 14h. Jovem trazido por colegas de faculdade.

PACIENTE

Lucas Martins, 21 anos, masculino, estudante universitário, sem comorbidades conhecidas.

QUEIXA PRINCIPAL

Cefaleia intensa de início há 12 horas, febre alta, fotofobia e rigidez do pescoço.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame físico dirigidos (pesquisa de sinais meníngeos).
2. Solicite e interprete exames complementares urgentes.
3. Inicie tratamento empírico antes do resultado da cultura.
4. Avalie necessidade de profilaxia para contactantes.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #250 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
108/70 mmHg	112 bpm	22 irpm	39,6 °C	97% (ar ambiente)	13 (O3V4M6)

EXAME FÍSICO GERAL

Mal estado geral, febril, prostrado, fotofobia intensa, fono-fobia.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: rigidez de nuca (mentoqueixo-esternal positivo), Kernig positivo bilateral, Brudzinski positivo, pupilas isocóricas fotorreativas, sem déficit motor focal.
- PELE: petéquias em tronco e membros inferiores (5–6 lesões).
- CARDIOVASCULAR: taquicardia sinusal, hipotensão limítrofe.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemograma	**Leuco 22.400/mm³ (87% segmentados, 8% bastões)**	4.500–11.000/mm³
PCR	**248 mg/L**	< 5 mg/L
Lactato	**3,8 mmol/L**	< 2,0 mmol/L
TC crânio	Sem lesão expansiva, sem desvio de linha média, cisterna basal pérvia	
LCR — Aspecto	**Turvo, xantocrômico**	Límpido e incolor
LCR — Células	**4.200 células/mm³ (92% PMN)**	< 5 células/mm³
LCR — Glicose	**28 mg/dL (glicemia 102 mg/dL)**	> 50% da glicemia
LCR — Proteína	**380 mg/dL**	15–45 mg/dL
LCR — Gram	**Diplococos gram-negativos**	

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC crânio: sem lesão expansiva, sem hidrocefalia, sem desvio de linha média. Cisterna basal pérvia.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #250 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca

NOTA AO AVALIADOR

Entregar resultado da TC antes da punção lombar. Entregar LCR após o candidato realizar a punção. Revelar petéquias espontaneamente durante exame físico.

PERFIL DO PACIENTE

Estudante universitário, mora em república com 5 colegas. Sem vacinação prévia para meningococo. Nega uso de drogas. Sem antecedentes.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, tô com a pior dor de cabeça da minha vida. Começou ontem à tarde e foi piorando. A luz me incomoda demais.”
Sobre febre	“Sim, fui medir em casa, tava 39,8. Tomei paracetamol mas não passou.”
Sobre rigidez de nuca	“Tô sentindo o pescoço duro, dói quando tento abaixar a cabeça.”
Sobre as manchas na pele	“Só percebi quando o colega falou. Apareceram hoje de manhã.”
Sobre vacinas	“Não, nunca tomei vacina de meningite não.”
Sobre contactantes	“Moro com mais 4 colegas na república. A gente fica junto o dia todo.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“Que que eu tenho, doutor? É meningite?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Mora em república com 5 estudantes — só revela se candidato perguntar sobre contactantes
- Sem vacinação para meningococo — revela se candidato perguntar sobre vacinas

COMPORTAMENTO DO ATOR

Extremamente prostrado, responde com esforço, queixa-se de dor à movimentação da cabeça. Fecha os olhos durante a consulta por fotofobia.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #250 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca

Meningite bacteriana por Neisseria meningitidis (meningococcemia), com petéquias e sinais meníngeos clássicos.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Meningite viral — entra por síndrome meníngea; sai pelo LCR purulento (PMN, glicose baixa, proteína alta) e petéquias
- Hemorragia subaracnóidea — entra por cefaleia súbita intensa; sai pela ausência de sangue no LCR e febre alta
- Encefalite viral (HSV) — entra por febre + alteração neurológica; sai pelo predomínio de sinais meníngeos e LCR purulento
- Abscesso cerebral — entra por febre + cefaleia; sai pela TC normal e LCR purulento sem massa

CONTEXTO CLÍNICO

Meningite meningocócica acomete principalmente jovens e adolescentes. A tríade clássica (febre, cefaleia, rigidez de nuca) está presente em < 50% — petéquias/púrpura são altamente sugestivas de meningococcemia e indicam urgência.

JUSTIFICATIVA

Tríade clínica clássica + petéquias + LCR purulento com diplococos gram-negativos + contexto epidemiológico (jovem universitário em república sem vacinação).

ANAMNESE ESPERADA

- Início e progressão da cefaleia
- Febre
- Fotofobia e fonofobia
- Rigidez de nuca
- Lesões cutâneas
- Contactantes
- Status vacinal
- Antecedentes de imunossupressão

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Kernig
- Brudzinski
- Rigidez de nuca
- Pesquisa de petéquias/púrpura
- Fundo de olho (papiledema)
- Glasgow
- Pupilas

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC crânio (antes de PL se Glasgow < 13 ou papiledema)	Excluir lesão expansiva antes da punção lombar	TC normal — PL liberada
Punção lombar com análise do LCR	Diagnóstico definitivo	LCR purulento, pleocitose PMN, glicose baixa, proteína alta, gram+ diplococos gram-neg

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Hemograma + PCR + lactato	Avaliar gravidade e resposta inflamatória sistêmica	Leucocitose com desvio, PCR elevado, lactato elevado
Hemocultura (2 amostras)	Identificação do agente etiológico	Positiva para N. meningitidis (resultado em 24–48h)

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: Ceftriaxona 2g IV de 12/12h (imediatamente — não aguardar LCR); Dexametasona 0,15 mg/kg IV de 6/6h por 4 dias (iniciar antes ou com 1ª dose do ATB); Profilaxia de contactantes: Rifampicina 600 mg VO de 12/12h por 2 dias (ou ciprofloxacino 500 mg dose única)
- Suporte: hidratação IV, analgesia, repouso em quarto escurecido; isolamento respiratório por 24h após início do ATB
- Notificação compulsória imediata (SINAN)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Informar diagnóstico ao paciente e família
- Explicar necessidade de tratamento imediato
- Notificar vigilância epidemiológica
- Orientar profilaxia dos contactantes
- Isolar o paciente

ERROS CRÍTICOS

- Aguardar resultado do LCR para iniciar antibiótico (cada hora de atraso aumenta mortalidade)
- Realizar punção lombar sem TC prévia em paciente com alteração de consciência ou papiledema
- Não indicar quimioprofilaxia para contactantes próximos
- Não notificar à vigilância epidemiológica (meningite bacteriana é notificação compulsória imediata)
- Não usar dexametasona adjuvante (reduz sequelas neurológicas)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #250 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia intensa, febre e rigidez de nuca

Meningite Bacteriana — Material de Estudo

Epidemiologia e Agentes Etiológicos	Pts	Avaliação
Neisseria meningitidis: jovens e adultos jovens, surtos em ambientes coletivos. Van de Beek et al. 2016	1	☐ A ☐ P ☐ I
Streptococcus pneumoniae: adultos > 50 anos, imunocomprometidos — maior mortalidade. Van de Beek et al. 2016	1	☐ A ☐ P ☐ I
Listeria monocytogenes: idosos, gestantes, imunossuprimidos — cobrir com ampicilina. IDSA Guidelines 2004	1	☐ A ☐ P ☐ I

Diagnóstico	Pts	Avaliação
Tríade clássica (febre + cefaleia + rigidez de nuca) presente em < 44% — não excluir ausência de um item. Attia et al. 1999	2	☐ A ☐ P ☐ I
Petéquias/púrpura: altamente sugestivas de meningococcemia — tratar sem aguardar exames. Diretrizes SBN 2022	2	☐ A ☐ P ☐ I
LCR bacteriano: turvo, PMN > 1000, glicose < 40 mg/dL (ou razão LCR/plasma < 0,4), proteína > 100 mg/dL. IDSA Guidelines 2004	2	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento	Pts	Avaliação
Antibiótico empírico imediato: ceftriaxona 2g IV 12/12h. Não aguardar resultado do LCR. IDSA Guidelines 2004	2	☐ A ☐ P ☐ I
Dexametasona 0,15 mg/kg IV 6/6h por 4 dias: iniciar com ou antes da 1ª dose do ATB — reduz surdez e mortalidade no pneumococo. De Gans & Van de Beek, NEJM 2002	2	☐ A ☐ P ☐ I
Cobertura adicional para Listeria (≥ 50 anos ou imunossuprimido): adicionar ampicilina 2g IV 4/4h. IDSA Guidelines 2004	1	☐ A ☐ P ☐ I

Profilaxia de Contactantes	Pts	Avaliação
Meningococo: Rifampicina 600 mg VO 12/12h por 2 dias (ou ciprofloxacino 500 mg dose única). MS/SVS Nota Técnica 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I
Contactantes próximos: coabitantes, namorado/a, colegas de república com contato face a face > 8h. MS/SVS Nota Técnica 2021	1	☐ A ☐ P ☐ I
Notificação compulsória imediata ao SINAN (< 24h). Portaria MS 264/2020	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **19** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #251 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Pior dor de cabeça da vida de início súbito

CENÁRIO

PS de hospital terciário, 16h. Paciente trazido por familiar após súbita cefaleia durante o exercício.

PACIENTE

Fernanda Lima, 47 anos, feminina, professora, hipertensa.

QUEIXA PRINCIPAL

Cefaleia de início súbito ("como uma bomba na cabeça") durante caminhada há 2 horas, acompanhada de náuseas, vômitos e breve perda de consciência.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame neurológico completo.
2. Solicite e interprete exames de imagem urgentes.
3. Avalie a gravidade pela escala de Hunt e Hess.
4. Indique conduta imediata e encaminhamento à neurocirurgia.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #251 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Pior dor de cabeça da vida de início súbito

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
186/106 mmHg	96 bpm	18 irpm	37,2 °C	97%	14 (O4V4M6)

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, consciente, orientada, extremamente ansiosa, fotofobia intensa.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: rigidez de nuca leve-moderada, Kernig negativo, sem déficit motor focal, pupilas isocóricas fotorreativas (3mm).
- FUNDO DE OLHO: hemorragias sub-hialóideas bilaterais (síndrome de Terson).
- CARDIOVASCULAR: taquicardia leve, PA elevada.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
TC crânio sem contraste	**Hiperdensidade nas cisternas basais e fissura silviana bilateral — padrão de HSA**	
Hemograma	Normal	
Coagulograma	Normal	
LCR (se TC negativa)	**Xantocrômico, hemácias 180.000/mm³, sem diminuição entre tubos**	

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC crânio sem contraste: hiperdensidade nas cisternas basais, fissura inter-hemisférica anterior e fissura silviana bilateral — padrão típico de HSA. Escala de Fisher = 3.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #251 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Pior dor de cabeça da vida de início súbito

NOTA AO AVALIADOR

Entregar TC imediatamente após solicitação. Se candidato não pedir TC mas pedir PL, entregar resultado de LCR xantocrômico. Fundo de olho: revelar hemorragias sub-hialóideas se candidato examinar.

PERFIL DO PACIENTE

Mulher de 47 anos, professora, HAS há 5 anos (uso irregular de losartana). Fumante (10 maços-ano). Irmão teve aneurisma cerebral aos 52 anos.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutora, nunca senti uma dor de cabeça assim. Foi como se explodisse uma bomba dentro da minha cabeça. Na hora eu desmaiei, acho que por uns segundos.”
Sobre a dor	“Atingiu o pico em segundos. Tô enjoada, vomitei duas vezes no carro. A luz tá me matando.”
Sobre dores de cabeça anteriores	“Tenho enxaqueca às vezes, mas nunca assim. Essa é completamente diferente.”
Sobre histórico familiar	“Meu irmão mais velho teve um aneurisma no cérebro há 2 anos. Ficou internado por semanas.”
Sobre o pescoço	“Sim, tô com o pescoço duro, dói quando abaixo a cabeça.”
Sobre medicações	“Tomo losartana pra pressão, mas às vezes esqueço. Não tomo nenhuma outra coisa.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“É um derrame? Eu tenho aneurisma como meu irmão?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- História familiar de aneurisma cerebral (irmão) — revela se candidato perguntar sobre família
- Tabagismo (10 maços-ano) — revela se perguntar sobre tabaco
- Uso irregular de losartana — revela se perguntar sobre adesão

COMPORTAMENTO DO ATOR

Extremamente ansiosa e com dor intensa (EVA 9/10). Fotofobia real — fecha os olhos. Pergunta repetidamente se vai morrer ou ficar com sequelas.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #251 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Pior dor de cabeça da vida de início súbito

Hemorragia subaracnóidea espontânea (HSA), provavelmente por rotura de aneurisma sacular, Hunt-Hess grau II, Fisher 3.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Meningite bacteriana — entra por cefaleia + rigidez de nuca; sai pelo início thunderclap, sem febre significativa e TC com hiperdensidade
- Migrânea — entra por cefaleia intensa; sai pelo padrão thunderclap (ápice em segundos) e perda de consciência
- AVC isquêmico — entra por déficit neurológico súbito; sai pela ausência de déficit focal e TC com hiperdensidade subaracnóidea
- HSA traumática — entra pelo sangue subaracnóideo; sai pela ausência de trauma e história de cefaleia thunderclap espontânea

CONTEXTO CLÍNICO

A HSA espontânea representa 5% dos AVCs mas tem mortalidade de 30–40%. 85% são causadas por rotura de aneurisma sacular. A cefaleia thunderclap ("pior dor da vida" com ápice em < 1 min) é o sinal cardinal. TC detecta 98% das HSAs nas primeiras 12 horas.

JUSTIFICATIVA

Cefaleia thunderclap, síncope, rigidez de nuca, hemorragias sub-hialóideas no FO, TC com hiperdensidade nas cisternas basais — todos critérios preenchidos.

ANAMNESE ESPERADA

- Caráter e início da cefaleia (thunderclap)
- Perda de consciência
- Náuseas/vômitos
- Rigidez de nuca
- História familiar de aneurisma
- HAS, tabagismo
- Anticoagulantes

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Escala de Hunt e Hess
- Escala de Fisher (imagem)
- Fundo de olho (hemorragia sub-hialóidea)
- Rigidez de nuca
- Déficit motor focal
- Pupilas

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC crânio sem contraste	Diagnóstico de HSA — sensibilidade 98% nas primeiras 12h	Hiperdensidade cisternas basais — Fisher 3
Punção lombar (se TC negativa)	LCR xantocrômico confirma HSA com TC negativa	Xantocromia + hemácias uniformes entre tubos
AngioTC cerebral	Identificar aneurisma e planejar clipagem/coiling	Aneurisma de comunicante posterior ou ACM
ECG	HSA pode causar alterações eletrocardiográficas (onda T invertida, QT prolongado)	Alterações de repolarização

CONDUTA ESPERADA

- Internação em UTI neurocirúrgica
- Repouso absoluto, quarto escurecido
- Nimodipino 60 mg VO de 4/4h por 21 dias (prevenção de vasoespasmo)
- Controle rigoroso de PA (evitar hipotensão)
- Analgesia (dipirona, morfina se necessário)
- Encaminhamento urgente à neurocirurgia para clipagem ou embolização do aneurisma
- Profilaxia de TVP

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar diagnóstico de sangramento cerebral
- Explicar necessidade de UTI e neurocirurgia urgente
- Abordar prognóstico com honestidade
- Obter TCLE para procedimento neurocirúrgico

ERROS CRÍTICOS

- Dispensar paciente com diagnóstico de enxaqueca sem TC ou PL
- Realizar PL sem TC prévia
- Não usar nimodipino (prevenção de vasoespasmo)
- Não encaminhar à neurocirurgia urgente
- Reduzir PA abruptamente (risco de isquemia cerebral antes de tratar o aneurisma)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #251 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Pior dor de cabeça da vida de início súbito

Hemorragia Subaracnóidea — Material de Estudo

Diagnóstico	Pts	Avaliação
Cefaleia thunderclap: ápice em < 1 minuto — sinal cardinal da HSA. "Pior cefaleia da vida". Edlow & Caplan, NEJM 2000	2	☐ A ☐ P ☐ I
TC sem contraste: sensibilidade 98% nas primeiras 12h, cai para < 50% após 7 dias. Perry et al. BMJ 2011	2	☐ A ☐ P ☐ I
Punção lombar: indicada quando TC negativa. Xantocromia visível após 2h do sangramento, persiste por 2 semanas. Edlow & Caplan 2000	2	☐ A ☐ P ☐ I

Escalas de Gravidade	Pts	Avaliação
Hunt e Hess: grau I (assintomático) a grau V (coma profundo) — correlaciona com prognóstico. Hunt & Hess 1968	1	☐ A ☐ P ☐ I
Fisher modificado: grau 1 (sem sangue) a grau 4 (hematoma intraventricular) — prediz risco de vasoespasmo. Frontera et al. 2006	1	☐ A ☐ P ☐ I

Complicações	Pts	Avaliação
Ressangramento: maior risco nas primeiras 24h (4%) — principal causa de morte precoce. Kassell et al. 1990	2	☐ A ☐ P ☐ I
Vasoespasmo: pico entre 4–14 dias — causa isquemia cerebral tardia; prevenção com nimodipino. Pickard et al. NEJM 1989	2	☐ A ☐ P ☐ I
Hidrocefalia: aguda (horas) ou crônica (semanas) — pode requerer DVE ou DVP. Diretrizes AHA/ASA 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento	Pts	Avaliação
Nimodipino 60 mg VO 4/4h por 21 dias: reduz isquemia por vasoespasmo em 34%. Pickard et al. NEJM 1989	2	☐ A ☐ P ☐ I
Tratamento do aneurisma: clipagem cirúrgica ou embolização endovascular — na primeira semana se possível. ISAT Trial 2002	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **17** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #252 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória

CENÁRIO

PS de hospital universitário, 10h. Paciente com Miastenia Gravis conhecida.

PACIENTE

Patrícia Souza, 38 anos, feminina, enfermeira, portadora de Miastenia Gravis há 4 anos.

QUEIXA PRINCIPAL

Piora progressiva da fraqueza muscular há 3 dias, com dificuldade para engolir e respirar nas últimas horas.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize avaliação neuromuscular e respiratória de urgência.
2. Diferencie crise miastênica de crise colinérgica.
3. Solicite exames complementares e avalie necessidade de suporte ventilatório.
4. Institua tratamento específico da crise miastênica.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #252 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	CVF
124/80 mmHg	102 bpm	26 irpm	37,4 °C	93% (ar ambiente)	1,2 L (22% do previsto)

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, consciente, ansiosa, voz nasal, disfagia para sólidos e líquidos, dispneia ao repouso.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: ptose palpebral bilateral, diplopia, fraqueza proximal dos membros (força 3/5), reflexos diminuídos. Teste do olhar sustentado: ptose após 60s (positivo para fadiga).
- RESPIRATÓRIO: uso de musculatura acessória, FR 26 irpm, MV reduzido nas bases, SpO2 93%.
- DIGESTIVO: disfagia para sólidos e líquidos.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
CVF (Capacidade Vital Forçada)	**1,2 L (22% do previsto)**	> 80% do previsto
PIM (Pressão Inspiratória Máxima)	**-18 cmH₂O**	< -30 cmH₂O indica IOT
Anti-AChR (ac anti-receptor acetilcolina)	**Positivo (título alto prévio)**	Negativo
Hemograma	Normal	
TC tórax	Timoma anterior mediastinal (conhecido)	

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC de tórax: timoma no mediastino anterior (diagnóstico prévio). Sem pneumonia aspirativa.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #252 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória

NOTA AO AVALIADOR

Revelar CVF e PIM quando candidato solicitar avaliação respiratória. A paciente está em uso de piridostigmina mas relata que a última dose foi há 6 horas (não é crise colinérgica).

PERFIL DO PACIENTE

Enfermeira, MG soropositiva (anti-AChR) há 4 anos, timoma ressecado há 2 anos. Em uso de piridostigmina 60 mg 4/4h e prednisona 40 mg/dia. Teve infecção urinária tratada com ciprofloxacino há 1 semana (potencial desencadeante).

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutora, minha miastenia tá em crise. Tô com dificuldade pra respirar e engolir. Fui piorando nos últimos 3 dias.”
Sobre respiração	“Ontem à noite eu acordei com falta de ar. Hoje de manhã ficou pior, consigo falar mas fico cansada.”
Sobre a medicação	“Tô tomando tudo certinho, piridostigmina e prednisona. Tomei a última dose de piridostigmina há umas 6 horas.”
Sobre fator desencadeante	“Tive uma infecção urinária semana passada, tomei ciprofloxacino. Será que foi isso?”
Sobre salivação excessiva ou diarreia	“Não, não tô com saliva demais nem diarreia. Pelo contrário, tô com a boca seca.”
Pergunta ativa	“Vai precisar me intubar, doutora? Tenho medo disso.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Uso de ciprofloxacino (fluoroquinolona piora MG) — revela se candidato perguntar sobre medicações recentes
- Sem sintomas colinérgicos (boca seca, não diarreia) — revela se candidato diferenciar crise miastênica de colinérgica

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansiosa, voz nasal e fraca, com pausas para respirar durante as falas. Demonstra esforço ao falar frases longas.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #252 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória

Crise miastênica grave com insuficiência respiratória iminente, possivelmente desencadeada por fluoroquinolona (ciprofloxacino).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Crise colinérgica (excesso de piridostigmina) — entra por fraqueza muscular em MG; sai pela ausência de salivação excessiva, miose, bradicardia, diarreia — e última dose há 6h
- Síndrome de Guillain-Barré — entra por fraqueza ascendente + IR; sai pela história de MG estabelecida e ptose/diplopia
- Botulismo — entra por fraqueza descendente; sai pela história de MG e ausência de ingesta suspeita
- Polimiosite — entra por fraqueza proximal; sai pela ptose, diplopia e contexto de MG estabelecida

CONTEXTO CLÍNICO

A crise miastênica é a complicação mais grave da Miastenia Gravis, com falência da musculatura respiratória. Fatores precipitantes incluem infecções, cirurgias, medicamentos (fluoroquinolonas, aminoglicosídeos, betabloqueadores) e retirada de imunossupressores.

JUSTIFICATIVA

CVF < 20% do previsto, PIM > -30 cmH_2O, SpO2 93% em ar ambiente, disfagia — critérios de IOT iminente. Contexto de MG estabelecida + uso de ciprofloxacino.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo de piora
- Disfagia e disfonia
- Última dose de piridostigmina
- Medicamentos novos (desencadeantes)
- Infecção recente
- Sintomas colinérgicos (diferencial)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Ptose e fadiga ocular (teste do olhar sustentado)
- Força muscular proximal
- FR e padrão respiratório
- SpO2
- Ausculta pulmonar
- Reflexos

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
CVF e PIM	Regra dos 20-30-40: CVF < 20%, PIM < 30 cmH_2O, PE < 40 cmH_2O = intubação iminente	CVF 22%, PIM -18 — intubação indicada
Gasometria arterial	Avaliar hipercapnia (sinal de falência ventilatória)	Hipoxemia + hipercapnia
Anticorpos anti-AChR	Confirma MG soropositiva e monitoriza atividade	Positivo — já conhecido

CONDUTA ESPERADA

- Suporte: IOT eletiva imediata (CVF < 20% e PIM > -30 cmH_2O); suspender piridostigmina durante crise (pode piorar secreções)
- Específico: Plasmaférese (5 sessões em dias alternados) OU Imunoglobulina IV (2 g/kg dividido em 2–5 dias)

- Imunossupressão: manter corticoide; suspender ciprofloxacino
- Suporte em UTI até desmame ventilatório

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar diagnóstico de crise miastênica
- Explicar necessidade de intubação
- Discutir opções terapêuticas (PLEX vs IVIG)
- Tranquilizar sobre reversibilidade da crise

ERROS CRÍTICOS

- Não reconhecer critérios para intubação iminente (regra dos 20-30-40)
- Continuar piridostigmina durante a crise (piora de secreções, dificulta desmame)
- Usar succinilcolina na IOT (resistência ao bloqueio despolarizante em MG)
- Não identificar ciprofloxacino como desencadeante e não suspendê-lo
- Confundir com crise colinérgica e reduzir piridostigmina (em vez de outras medidas)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #252 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Fraqueza muscular progressiva e dificuldade respiratória

Crise Miastênica — Material de Estudo

Definição e Desencadeantes	Pts	Avaliação
Crise miastênica: exacerbação grave com falência respiratória, requerendo suporte ventilatório. Gilhus NE, NEJM 2016	2	☐ A ☐ P ☐ I
Precipitantes: infecções (principal), cirurgias, medicamentos (fluoroquinolonas, aminoglicosídeos, betabloqueadores, cloroquina), gravidez, retirada de corticoide. Diretrizes ABN 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I

Avaliação Respiratória — Regra dos 20-30-40	Pts	Avaliação
CVF < 20% do previsto, PIM > -30 cmH_2O, PEM < 40 cmH_2O: intubação iminente. Seneviratne et al. 2008	2	☐ A ☐ P ☐ I
Não aguardar SpO2 cair ou PaCO2 subir — a oxigenação se mantém tarde demais; a hipercapnia é sinal tardio de falência. Zinman L, Neurol Clin 2010	2	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento Específico	Pts	Avaliação
Plasmaférese (PLEX): 5 sessões em dias alternados — resposta em 1–2 semanas. Gajdos et al. 1997	2	☐ A ☐ P ☐ I
Imunoglobulina IV (IVIG): 2 g/kg em 2–5 dias — eficácia similar à PLEX, mais prático. Barth et al. 2011	2	☐ A ☐ P ☐ I
Suspender piridostigmina durante a crise: aumenta secreções e dificulta desmame ventilatório. Diretrizes ABN 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **14** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #253 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias

CENÁRIO

PS de hospital geral, 09h. Paciente encaminhado pela UBS por fraqueza progressiva.

PACIENTE

Antônio Pereira, 52 anos, masculino, caminhoneiro, sem comorbidades conhecidas.

QUEIXA PRINCIPAL

Fraqueza muscular progressiva que começou nos pés há 5 dias e subiu para as coxas e mãos, com formigamento nos extremidades.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame neurológico completo.
2. Solicite exames complementares.
3. Estabeleça o diagnóstico e avalie gravidade.
4. Inicie suporte e tratamento específico.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #253 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	CVF
132/84 mmHg	96 bpm	20 irpm	36,8 °C	97%	2,8 L (72% do previsto)

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, consciente, orientado, ansioso, marcha atáxica com base alargada.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: fraqueza flácida tetraparesia (força 3/5 MMII, 4/5 MMSS), arreflexia generalizada, parestesias em luva e meia, sem nível sensitivo definido, disfagia leve.
- SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO: FC 96 bpm variável (disautonomia).
- RESPIRATÓRIO: FR 20, CVF 72% do previsto.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
LCR — Células	3 células/mm³	< 5/mm³
LCR — Proteína	**186 mg/dL**	15–45 mg/dL
LCR — Glicose	68 mg/dL	Normal
ENMG (eletroneuromiografia)	**Redução de velocidade de condução nervosa, aumento de latências distais — padrão desmielinizante**	
Anti-gangliosídeos (anti-GM1)	**Positivo**	Negativo

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RM de coluna: sem compressão medular, sem hematoma epidural.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #253 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias

NOTA AO AVALIADOR

Revelar LCR após punção lombar. Revelar ENMG após solicitação. A variação da FC durante o exame é sinal de disautonomia — mencionar espontaneamente durante exame.

PERFIL DO PACIENTE

Caminhoneiro, viajou para o interior de SP há 2 semanas. Teve diarreia aguda há 12 dias (infecção por Campylobacter jejuni — não confirmada, mas suspeita). Sem vacinação recente. Não faz uso de medicamentos.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, começou com um formigamento nos pés semana passada. Depois foi ficando fraco, e ontem as mãos também. Tô com dificuldade pra andar.”
Sobre progressão	“Começou nos pés e foi subindo. Em 5 dias chegou até as coxas e as mãos.”
Sobre diarreia	“Ih, é verdade, tive uma diarreia feia há umas 2 semanas. Três dias de diarreia com febre. Achei que tinha sido comida estragada.”
Sobre dificuldade para respirar	“Tô um pouco cansado, mas não tô com falta de ar na repouso não.”
Sobre a dor	“Tenho uma dor nas costas intensa, bem diferente da dor de coluna normal.”
Pergunta ativa	“Isso é grave doutor? Vai paralisar tudo?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Gastroenterite há 12 dias (Campylobacter suspeito) — revela se candidato perguntar sobre infecção prévia
- Dor lombar intensa — revela se candidato perguntar sobre dor

COMPORTAMENTO DO ATOR

Assustado com a progressão da fraqueza. Colaborativo. Levemente disártrico. Anda com dificuldade — base alargada.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #253 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias

Síndrome de Guillain-Barré (variante clássica AIDP — polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda), pós-infecciosa (provável Campylobacter jejuni).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Mielite transversa — entra por fraqueza ascendente; sai pela arreflexia, ausência de nível sensitivo e RM de coluna normal
- Botulismo — entra por fraqueza flácida descendente; sai pela progressão ascendente e contexto infeccioso prévio
- Compressão medular — entra por déficit motor; sai pela arreflexia, sem nível sensitivo e RM normal
- Hipocalemia grave — entra por fraqueza flácida; sai pelo LCR com dissociação albuminocitológica e ENMG desmielinizante

CONTEXTO CLÍNICO

Guillain-Barré é a principal causa de paralisia flácida aguda no mundo. Frequentemente pós-infecciosa (Campylobacter, CMV, EBV, SARS-CoV-2). A dissociação albumino-citológica no LCR (proteína alta, células normais) é característica.

JUSTIFICATIVA

Fraqueza flácida ascendente, arreflexia generalizada, dissociação albumino-citológica no LCR (proteína 186 mg/dL, 3 células), ENMG desmielinizante, antecedente de gastroenterite — critérios diagnósticos completos.

ANAMNESE ESPERADA

- Início e progressão da fraqueza (ascendente?)
- Parestesias
- Dor lombar
- Infecção precedente (2–4 semanas)
- Vacinações recentes
- Dificuldade para respirar
- Disfagia
- Alterações autonômicas

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Força muscular proximal e distal
- Reflexos tendíneos
- Sensibilidade
- Marcha
- CVF e PIM
- FC (disautonomia)
- Nervos cranianos

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Punção lombar com análise do LCR	Dissociação albumino-citológica: hallmark do SGB	Proteína 186 mg/dL, células 3/mm³
ENMG	Confirma desmielinização e diferencia variantes	Redução de velocidade de condução — AIDP
CVF e PIM seriados	Monitorização respiratória — principal causa de morte	CVF 72% — ainda não na faixa de IOT

Exame	Justificativa	Resultado esperado
RM de coluna	Excluir compressão medular	Sem compressão

CONDUTA ESPERADA

- Internação em UTI para monitorização respiratória e autonômica
- Monitorização seriada de CVF e PIM (a cada 4–6h nas primeiras 24h)
- Específico: IVIG 0,4 g/kg/dia por 5 dias OU Plasmaférese (5 sessões) — eficácia equivalente
- Suporte: fisioterapia motora e respiratória, heparina profilática (TVP), cuidados com disfagia

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar diagnóstico e prognóstico (80% recuperação completa em 1 ano)
- Informar sobre necessidade de UTI e monitorização
- Orientar sobre fisioterapia
- Preparar para possível intubação se CVF cair

ERROS CRÍTICOS

- Não monitorizar função respiratória seriada
- Aguardar hipercapnia para intubar (a oxigenação é tardia na falência neuromuscular)
- Não usar IVIG nem plasmaférese
- Usar corticoide isolado (não tem benefício no SGB clássico e pode piorar)
- Alta hospitalar sem internação para monitorização (risco de deterioração rápida)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #253 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Fraqueza nos pés que subiu para as pernas em 5 dias

Síndrome de Guillain-Barré — Material de Estudo

Definição e Fisiopatologia	Pts	Avaliação
Polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, autoimune, pós-infecciosa. Desmielinização (AIDP) ou axonal (AMAN/AMSAN). Willison et al. Lancet 2016	1	☐ A ☐ P ☐ I
Agentes desencadeantes: Campylobacter jejuni (mais comum), CMV, EBV, SARS-CoV-2, influenza. Willison et al. Lancet 2016	1	☐ A ☐ P ☐ I

Diagnóstico	Pts	Avaliação
Critérios de Brighton: fraqueza flácida bilateral + hiporreflexia/arreflexia + dissociação albumino-citológica no LCR. Fokke et al. Brain 2014	2	☐ A ☐ P ☐ I
Dissociação albumino-citológica: proteína > 45 mg/dL com < 10 células/mm³ — hallmark do SGB. Van den Berg et al. 2014	2	☐ A ☐ P ☐ I

Monitorização Respiratória	Pts	Avaliação
Regra dos 20-30-40: CVF < 20%, PIM > -30 cmH_2O, PEM < 40 cmH_2O = intubação. Lawn & Wijdicks 1999	2	☐ A ☐ P ☐ I
Monitorização seriada (4–6h nas primeiras 24h): deterioração pode ser rápida e imprevisível. Diretrizes ABN 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento Específico	Pts	Avaliação
IVIG 0,4 g/kg/dia por 5 dias ou 1 g/kg/dia por 2 dias: primeira escolha em adultos e crianças. Hughes et al. Cochrane 2014	2	☐ A ☐ P ☐ I
Plasmaférese (5 sessões): eficácia equivalente à IVIG. Preferida em insuficiência renal ou trombose. French Cooperative Group 1997	2	☐ A ☐ P ☐ I
Corticosteroides isolados: não têm benefício comprovado no SGB — não usar. Hughes et al. Cochrane 2016	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **16** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #254 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico

CENÁRIO

PS de hospital geral, 20h. Paciente trazido por vizinhos após ser encontrado confuso em casa.

PACIENTE

Carlos Rocha, 55 anos, masculino, desempregado, etilista crônico.

QUEIXA PRINCIPAL

Confusão mental, instabilidade para andar e "olhos tortos" notados há 2 dias.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame neurológico completo.
2. Identifique a tríade clínica diagnóstica.
3. Solicite exames e inicie tratamento emergencial.
4. Avalie complicações associadas ao etilismo.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #254 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
118/76 mmHg	88 bpm	16 irpm	36,9 °C	96%	12 (O3V4M5)

EXAME FÍSICO GERAL

Mau estado geral, desnutrido, confuso, desorientado no tempo e espaço, hálito alcoólico.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: oftalmoplegia (paresia do VI nervo bilateral — limitação da abdução), nistagmo horizontal, ataxia cerebelar (marcha impossível sem apoio, Romberg positivo), encefalopatia (confusão, desorientação).
- NUTRICIONAL: desnutrição moderada, glossite, queilite angular.
- CARDIOVASCULAR: sem sopros.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Tiamina sérica	**18 nmol/L**	70–180 nmol/L
Glicemia	88 mg/dL	70–99 mg/dL
Sódio	**128 mEq/L**	136–145 mEq/L
ALT	**82 U/L**	< 40 U/L
GGT	**312 U/L**	< 55 U/L
Hemograma	**Macrocitose (VCM 108 fL), anemia leve (Hb 10,2 g/dL)**	VCM 80–100 fL

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RM de encéfalo: hipersinal em T2/FLAIR simétrico nos corpos mamilares, tálamo medial e aqueduto de Sylvius — padrão de Wernicke.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #254 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico

NOTA AO AVALIADOR

RM não disponível no PS — descrever ao candidato se solicitada. Nível de tiamina: revelar apenas se candidato solicitar. Não administrar glicose antes de tiamina!

PERFIL DO PACIENTE

Etilista crônico há 20 anos, consome > 300 g de etanol/dia. Desnutrido, raramente come. Mora sozinho. Já teve abstinência com tremores no passado.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, tô meio perdido... Não consigo andar direito. Os meus olhos tão... diferentes.”
Sobre álcool	“Bebo sim... todo dia. Já faz muitos anos. Às vezes não como, só bebo.”
Sobre alimentação	“Não tô comendo muito não. Quando tô bebendo não sinto fome.”
Sobre os olhos	“Tô vendo duplo às vezes. E os olhos ficam tremendo sozinhos.”
Sobre confusão	“Não sei bem que dia é hoje... tô um pouco perdido.”
Pergunta ativa	“É do álcool isso, doutor?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Episódios de abstinência com tremores no passado — revela se candidato perguntar sobre abstinência
- Alimentação extremamente pobre há semanas — revela se candidato perguntar sobre alimentação

COMPORTAMENTO DO ATOR

Confuso, desorientado, responde com dificuldade e frases curtas. Olhar divergente visível. Não consegue se levantar sem apoio.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #254 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico

Encefalopatia de Wernicke por deficiência de tiamina (vitamina B1) em contexto de etilismo crônico e desnutrição.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- AVC de tronco/cerebelo — entra por ataxia e oftalmoplegia; sai pelo contexto de etilismo, desnutrição e deficiência de tiamina
- Síndrome de abstinência alcoólica — entra por confusão em etilista; sai pela tríade de Wernicke (oftalmoplegia + ataxia + confusão)
- Meningite bacteriana — entra por confusão + instabilidade; sai pela ausência de febre, rigidez de nuca e LCR normal
- Encefalite límbica — entra por confusão; sai pelo contexto de etilismo severo e tríade típica de Wernicke

CONTEXTO CLÍNICO

A encefalopatia de Wernicke é subdiagnosticada (diagnóstico correto em vida em apenas 20% dos casos). A tríade clássica (oftalmoplegia + ataxia + confusão) está completa em apenas 16% dos pacientes. O diagnóstico é clínico — não aguardar RM ou dosagem de tiamina para tratar.

JUSTIFICATIVA

Tríade completa: encefalopatia (confusão, desorientação), oftalmoplegia (paresia VI par, nistagmo) e ataxia cerebelar — em etilista crônico desnutrido. Tiamina sérica baixa.

ANAMNESE ESPERADA

- Etilismo (quantidade e tempo)
- Alimentação
- Episódios de abstinência prévios
- Início dos sintomas oculares, ataxia, confusão
- Uso de vitaminas

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Pares cranianos (VI e VIII)
- Nistagmo
- Marcha e Romberg
- Glasgow
- Sinais de desnutrição
- Estigmas de hepatopatia alcóolica

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Glicemia capilar	Excluir hipoglicemia	88 mg/dL — normal
Tiamina sérica	Confirma deficiência	18 nmol/L — baixo
Eletrólitos	Hiponatremia frequente no etilismo	Na 128 mEq/L — hiponatremia
Função hepática	Avaliar hepatopatia alcoólica	ALT e GGT elevados
RM encéfalo	Hipersinal em corpos mamilares e tálamo medial (típico)	Padrão de Wernicke em FLAIR/T2

CONDUTA ESPERADA

- URGENTE: Tiamina 500 mg IV de 8/8h por 3 dias (ANTES de qualquer glicose) → depois tiamina 250 mg IM/IV por mais 5 dias → manutenção oral 100 mg/dia

- Suporte: Glicose IV somente após tiamina; correção de hiponatremia; hidratação; suporte nutricional
- Internação para monitorização e prevenção de síndrome de abstinência alcoólica

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar diagnóstico de deficiência vitamínica
- Enfatizar que álcool e desnutrição causaram o quadro
- Orientar sobre risco de Korsakoff se não tratado
- Encaminhar para serviço de dependência química

ERROS CRÍTICOS

- Administrar glicose IV antes de tiamina (preciptita ou agrava encefalopatia de Wernicke)
- Aguardar dosagem de tiamina ou RM para iniciar tratamento
- Usar dose inadequada de tiamina (oral ou 100 mg IM — dose de tratamento é 500 mg IV)
- Não corrigir hiponatremia associada
- Alta sem tratar e sem encaminhamento para dependência química

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #254 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Confusão mental e dificuldade para andar em etilista crônico

Encefalopatia de Wernicke — Material de Estudo

Fisiopatologia	Pts	Avaliação
Deficiência de tiamina (B1): cofator essencial no metabolismo da glicose (piruvato desidrogenase, α-cetoglutarato desidrogenase). Harper et al. 2006	1	☐ A ☐ P ☐ I
Causa morte neuronal principalmente nos corpos mamilares, tálamo medial, tecto do mesencéfalo e cerebelo. Victor et al. 1989	1	☐ A ☐ P ☐ I

Diagnóstico Clínico	Pts	Avaliação
Tríade de Wernicke: oftalmoplegia (paresia VI, nistagmo) + ataxia cerebelar + encefalopatia. Completa em apenas 16% dos pacientes. Harper 2006	2	☐ A ☐ P ☐ I
Critérios de Caine: 2 de 4 critérios — (1) desnutrição, (2) oftalmoplegia, (3) alteração cerebelar, (4) encefalopatia. Caine et al. 1997	2	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento	Pts	Avaliação
Tiamina 500 mg IV de 8/8h por 3 dias ANTES de qualquer glicose — regra absoluta. EFNS Guidelines 2010	2	☐ A ☐ P ☐ I
Administrar glicose antes de tiamina pode precipitar ou agravar a encefalopatia de Wernicke. EFNS Guidelines 2010	2	☐ A ☐ P ☐ I
Sequela sem tratamento: síndrome de Korsakoff — amnésia anterógrada irreversível + confabulação (80% dos casos de Wernicke não tratados). Thomson & Marshall 2006	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **12** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #255 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE

CENÁRIO

PS de pronto-socorro, 23h. Paciente trazido por familiares após acidente de moto.

PACIENTE

Felipe Castro, 25 anos, masculino, entregador, sem antecedentes.

QUEIXA PRINCIPAL

Cefaleia intensa progressiva, vômitos em jato (3 episódios) e sonolência crescente após queda de moto há 3 horas. Usava capacete.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize avaliação neurológica com escala de Glasgow e pupilas.
2. Solicite e interprete TC de crânio urgente.
3. Reconheça os sinais de HIC e aplique medidas de controle.
4. Indique condutas definitivas e comunique à neurocirurgia.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #255 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
162/96 mmHg	58 bpm	16 irpm	36,8 °C	96%	11 (O3V3M5) — deteriorando

EXAME FÍSICO GERAL

Sonolento, confuso, responde a comandos simples com dificuldade.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: Glasgow 11 (deteriorando — era 14 na chegada), anisocoria (pupila D 6mm, L 3mm, D com resposta fotomotora lenta — sinal de herniação transtentorial), déficit motor leve em MIE.
- FUNDO DE OLHO: papiledema bilateral.
- CARDIOVASCULAR: bradicardia relativa (FC 58 bpm), PA elevada — Tríade de Cushing parcial.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
TC crânio sem contraste	**Hiperdensidade lenticular biconvexa na região temporal direita (hematoma extradural). Desvio de linha média 7mm para esquerda. Apagamento do sulco temporal D.**	
Hemograma	Normal	
Coagulograma	INR 1,0 — normal	

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC crânio sem contraste: imagem hiperdensa biconvexa na região temporal-parietal direita (hematoma extradural). Desvio de linha média de 7mm para esquerda. Apagamento do sulco temporal ipsilateral.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #255 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE

NOTA AO AVALIADOR

TC revelar imediatamente após solicitação — é urgência neurocirúrgica. Anisocoria deve ser mencionada no exame físico espontaneamente durante avaliação das pupilas.

PERFIL DO PACIENTE

Jovem de 25 anos, entregador de moto, usava capacete aberto. TCE moderado-grave. Sem comorbidades, sem uso de anticoagulantes.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal (paciente confuso)	“Minha cabeça... tá doendo muito... (vomita)”
Familiar — sobre o acidente	“Ele bateu a cabeça, caiu da moto. Na hora ainda falava normal, mas foi ficando mais sonolento. Agora tá difícil de acordar.”
Familiar — sobre perda de consciência	“Perdeu a consciência uns 5 minutos logo depois do acidente, depois acordou. Mas agora tá caindo no sono de novo.”
Familiar — sobre medicações	“Não toma nada, é jovem e saudável.”
Pergunta ativa	“Tem alguma coisa grave na cabeça dele, doutor?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Intervalo lúcido (perdeu consciência → acordou → piora) — revela se candidato perguntar sobre evolução
- Usava capacete aberto — revela se candidato perguntar sobre EPI

COMPORTAMENTO DO ATOR

Sonolento, responde monossilabicamente. Vomita durante a consulta. Vai deteriorando ao longo do caso — quando o candidato demorar, aumentar a sonolência.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #255 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE

Hematoma extradural temporal direito com hipertensão intracraniana e sinais de herniação transtentorial iminente (anisocoria, tríade de Cushing parcial).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Hematoma subdural agudo — entra por TCE + HIC; sai pela imagem biconvexa (extradural) vs côncavo-convexa (subdural)
- Contusão cerebral — entra por TCE + deterioração; sai pela hiperdensidade biconvexa típica do extradural
- Hemorragia subaracnóidea traumática — entra por TCE; sai pela imagem biconvexa focal e desvio de linha média

CONTEXTO CLÍNICO

O hematoma extradural é clássico em jovens após TCE temporal (fratura do temporal com rotura da artéria meníngea média). O "intervalo lúcido" (perda de consciência → recuperação → deterioração) é patognomônico. Urgência neurocirúrgica absoluta.

JUSTIFICATIVA

TCE com intervalo lúcido, deterioração progressiva do Glasgow, anisocoria, tríade de Cushing parcial (HAS + bradicardia), papiledema bilateral, TC com hematoma extradural biconvexo com desvio de 7 mm.

ANAMNESE ESPERADA

- Mecanismo do trauma
- Intervalo lúcido
- Perda de consciência
- Evolução do Glasgow
- Vômitos
- Anticoagulantes
- Comorbidades

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Glasgow seriado
- Pupilas (anisocoria = sinal de herniação)
- Fundo de olho (papiledema)
- PA e FC (tríade de Cushing)
- Déficit motor focal
- Sinais de fratura de base

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC crânio sem contraste urgente	Diagnóstico e planejamento cirúrgico	Hematoma extradural biconvexo, desvio 7mm — cirurgia imediata
Gasometria arterial	Guiar hiperventilação emergencial se indicado	PaCO2 atual para ajuste
Coagulograma	Avaliar antes de cirurgia	Normal

CONDUTA ESPERADA

- Emergencial: Cabeceira 30°; IOT se Glasgow ≤ 8; Hiperventilação controlada (PCO2 35–40 mmHg como ponte) se herniação iminente; Manitol 1 g/kg IV ou solução salina hipertônica 3%
- Cirúrgico: Craniotomia de urgência para drenagem do hematoma (indicação: hematoma > 30 mL, desvio > 5 mm, Glasgow deteriorando)

- Neurocirurgia: acionar imediatamente

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar achados à neurocirurgia imediatamente
- Informar família sobre gravidade e necessidade de cirurgia urgente
- Explicar risco de herniação sem tratamento

ERROS CRÍTICOS

- Não reconhecer anisocoria como sinal de herniação transtentorial iminente
- Não acionar neurocirurgia imediatamente após TC
- Realizar punção lombar em paciente com sinais de HIC (risco de herniação)
- Não manter cabeceira a 30°
- Aguardar mais exames antes de acionar cirurgia urgente

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #255 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Cefaleia progressiva, vômitos em jato e sonolência após TCE

Hipertensão Intracraniana — Material de Estudo

Fisiopatologia e Tríade de Cushing	Pts	Avaliação
Doutrina de Monro-Kellie: volume intracraniano fixo (cérebro + LCR + sangue). Aumento de qualquer componente eleva a PIC. Monro-Kellie doctrine	1	☐ A ☐ P ☐ I
Tríade de Cushing: HAS + bradicardia + irregularidade respiratória — sinal de herniação iminente. Diretrizes ATLS 10ª ed.	2	☐ A ☐ P ☐ I
Normal: PIC < 15 mmHg. Tratamento agressivo: PIC > 20–22 mmHg por > 5 min. Carney et al. Neurosurgery 2017	1	☐ A ☐ P ☐ I

Hematoma Extradural	Pts	Avaliação
Imagem biconvexa hiperdensa — clássico. Rotura da artéria meníngea média (fratura temporal). ATLS 10ª ed.	2	☐ A ☐ P ☐ I
Intervalo lúcido: perda de consciência imediata → recuperação transitória → deterioração progressiva (patognomônico). Bullock et al. Neurosurgery 2006	2	☐ A ☐ P ☐ I
Cirurgia imediata se: hematoma > 30 mL, espessura > 15 mm, desvio > 5 mm, ou deterioração do Glasgow. Bullock et al. Neurosurgery 2006	2	☐ A ☐ P ☐ I

Medidas de Controle da PIC	Pts	Avaliação
Cabeceira 30° (reduz PIC sem comprometer perfusão cerebral). Carney et al. 2017	1	☐ A ☐ P ☐ I
Osmoterapia: Manitol 0,25–1 g/kg IV (efeito em 15 min, dura 90 min) ou Solução salina hipertônica 3%. Diretrizes BTF 2016	2	☐ A ☐ P ☐ I
Hiperventilação (PCO2 35 mmHg): medida de ponte — vasoconstrição cerebral temporária. Não manter > 30 min. Diretrizes BTF 2016	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **14** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Emergencias Neurologicas · Estação #256 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia

CENÁRIO

PS de hospital universitário, 11h. Jovem encaminhada pela UPA com cefaleia refratária.

PACIENTE

Juliana Mendes, 28 anos, feminina, estudante, em uso de anticoncepcional oral.

QUEIXA PRINCIPAL

Cefaleia progressiva de forte intensidade há 5 dias, pior ao deitar, com déficit visual e convulsão focal em MSD há 6 horas.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame neurológico completo.
2. Solicite imagens adequadas para o diagnóstico.
3. Inicie anticoagulação e trate complicações.
4. Investigue a causa predisponente.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Emergencias Neurologicas · Estação #256 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Glasgow
138/88 mmHg	92 bpm	18 irpm	37,0 °C	98%	14 (O4V4M6)

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, consciente, orientada, com cefaleia intensa (EVA 8/10), fotofobia leve.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- NEUROLÓGICO: paresia discreta em MSD (4/5), sem afasia, reflexo cutâneo-plantar indiferente à D. Fundo de olho: papiledema bilateral. Kernig e Brudzinski negativos.
- CARDIOVASCULAR: sem sopros, ritmo regular.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
RM crânio + venografia (AngioRM venosa)	**Ausência de fluxo no seio sagital superior e seio transverso D — trombose venosa cerebral extensa**	
TC crânio s/ contraste	**Hiperdensidade no seio sagital superior (sinal da corda) + área de infarto hemorrágico parietal D**	
D-dímero	**3.840 ng/mL**	< 500 ng/mL
Coagulograma	Normal	
Mutação fator V Leiden	**Heterozigota**	Ausente

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC crânio: hiperdensidade linear no seio sagital superior (sinal da corda), infarto hemorrágico parietal D. RM/venografia: ausência de fluxo no seio sagital superior e seio transverso D.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Emergencias Neurologicas · Estação #256 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia

NOTA AO AVALIADOR

RM venosa é o exame de escolha — entregar após solicitação. TC pode mostrar sinal da corda. Fator V Leiden: revelar apenas se candidato solicitar trombofilia.

PERFIL DO PACIENTE

Estudante, 28 anos, ACO oral há 2 anos (etinilestradiol + drospirenona). Fumante (5 cigarros/dia). Trombofilia (fator V Leiden heterozigoto — diagnóstico familiar). Sem antecedentes de AVCs.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutora, essa dor de cabeça tá me destruindo há 5 dias. Tomei tudo quanto é remédio e não passa. Hoje de manhã tive uma espécie de espasmo no braço direito.”
Sobre a dor	“Piora quando deito. É uma pressão na cabeça toda. Tô com dificuldade pra enxergar, fica borrado às vezes.”
Sobre anticoncepcional	“Tomo pílula há 2 anos. Minha ginecologista sabe.”
Sobre trombofilia	“Meu pai tem trombofilia, fator V Leiden ele disse. Nunca me examinaram pra isso.”
Sobre tabagismo	“Fumo umas 5 a 6 por dia, tô tentando parar.”
Pergunta ativa	“Pode ser coisa grave? Pode ser trombose?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Trombofilia familiar (Fator V Leiden) — revela se candidato perguntar sobre histórico familiar de trombose
- Tabagismo — revela se candidato perguntar
- ACO há 2 anos sem rastreio de trombofilia — revela se candidato perguntar sobre ACO

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansiosa e com dor intensa. Fotofobia — resiste à luz. Relata claramente a história se perguntada diretamente.

GABARITO

Emergencias Neurologicas · Estação #256 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia

Trombose venosa cerebral (seio sagital superior e seio transverso D) em paciente com trombofilia (Fator V Leiden) e ACO, com infarto hemorrágico cortical e convulsão focal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- AVC isquêmico arterial — entra pelo déficit focal; sai pela TC com hiperdensidade venosa, papiledema e origem multifocal do infarto
- Meningite bacteriana — entra por cefaleia + déficit; sai pela ausência de síndrome meníngea franca e pela venografia diagnóstica
- Hemorragia subaracnóidea — entra por cefaleia intensa; sai pela ausência de thunderclap e venografia com trombose
- Tumor cerebral — entra por HIC progressiva; sai pelo infarto hemorrágico agudo e venografia positiva

CONTEXTO CLÍNICO

A TVC é rara (3–4/milhão/ano) mas com prognóstico favorável se diagnosticada e tratada. Acomete principalmente mulheres jovens em uso de ACO, gestantes e puérperas, portadoras de trombofilias. Causa cefaleia progressiva (principal sintoma) + HIC + déficit focal + crises epilépticas.

JUSTIFICATIVA

Jovem do sexo feminino, ACO + tabagismo + fator V Leiden (tríade de risco para TVC), cefaleia progressiva com piora ao deitar, papiledema, déficit focal e crise focal — RM venosa confirmando trombose do SSS.

ANAMNESE ESPERADA

- Caráter e tempo da cefaleia
- Convulsões
- Déficit focal
- ACO e tipo
- Tabagismo
- Histórico familiar de trombose
- Gestação/puerpério
- Infecção recente

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Glasgow
- Déficit motor
- Fundo de olho (papiledema)
- Reflexos
- Sinais meníngeos (para diagnóstico diferencial)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
RM crânio + venografia (AngioRM)	Gold standard para diagnóstico de TVC	Ausência de fluxo no SSS e seio transverso D
TC crânio sem contraste	Disponível no PS — sinal da corda e infarto hemorrágico	Hiperdensidade no SSS + infarto hemorrágico parietal D
D-dímero	VPN alto para TVC se normal	3.840 ng/mL — elevado
Trombofilia (Fator V, Protrombina, Proteína C e S, ATIII)	Investigar causa predisponente	Fator V Leiden heterozigoto

CONDUTA ESPERADA

- Anticoagulação: Heparina não fracionada IV (alvo TTPA 60–80s) ou Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h — MESMO na presença de infarto hemorrágico (não é contraindicação em TVC)
- Antiepiléptico: Levetiracetam 500 mg IV 12/12h para convulsão focal
- Suspender ACO imediatamente
- Não fumar
- Anticoagulação oral por 3–12 meses (varfarina ou NOAC) após fase aguda

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar diagnóstico de trombose venosa no cérebro
- Orientar sobre suspensão do ACO
- Discutir rastreio de trombofilia
- Informar sobre anticoagulação prolongada

ERROS CRÍTICOS

- Não anticoagular por medo da hemorragia (a anticoagulação é indicada mesmo com infarto hemorrágico em TVC)
- Não pedir venografia (TC isolada pode ser normal em 30% dos casos)
- Não suspender o anticoncepcional oral
- Não investigar trombofilia subjacente
- Realizar punção lombar antes de excluir HIC significativa (papiledema presente)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Emergencias Neurologicas · Estação #256 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Cefaleia progressiva há 5 dias em jovem com trombofilia

Trombose Venosa Cerebral — Material de Estudo

Epidemiologia e Fatores de Risco	Pts	Avaliação
TVC acomete predominantemente mulheres jovens (3:1 F:M). Incidência: 3–4/milhão/ano. Ferro et al. Stroke 2004	1	☐ A ☐ P ☐ I
Principais fatores: ACO (OR 13–22), gestação/puerpério, trombofilias, infecção, tumores, desidratação. ISCVT Study 2004	2	☐ A ☐ P ☐ I

Diagnóstico	Pts	Avaliação
Cefaleia progressiva é o sintoma mais frequente (90% dos casos). Piora ao deitar (HIC posicional). Ferro et al. 2004	2	☐ A ☐ P ☐ I
Gold standard: RM + venografia (AngioRM ou AngioTC venosa). EFNS Guidelines 2010	2	☐ A ☐ P ☐ I
Sinal da corda na TC sem contraste: hiperdensidade linear no seio dural. Presente em 20–30% dos casos. Leach et al. Neuroradiology 2006	1	☐ A ☐ P ☐ I
D-dímero normal tem alto VPN para TVC (exceto formas crônicas). Kosior et al. 2011	1	☐ A ☐ P ☐ I

Tratamento	Pts	Avaliação
Anticoagulação plena é o tratamento de escolha — INCLUSIVE na presença de infarto hemorrágico (a hemorragia na TVC é venosa, não arterial). Einhäupl et al. NEJM 2002	2	☐ A ☐ P ☐ I
Heparina não fracionada IV ou enoxaparina SC na fase aguda; seguida de varfarina ou NOAC por 3–12 meses. EFNS Guidelines 2010	2	☐ A ☐ P ☐ I
Suspender ACO imediatamente. Investigar e tratar causa subjacente. Diretrizes SBN 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **14** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado